



Capítulo 3: El Trauma Colectivo y el Colapso del Lazo Social

Más allá del prisma

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

Introducción: El sufrimiento más allá de las paredes del consultorio

Durante décadas, la metapsicología clásica operó bajo el supuesto implícito de que el consultorio analítico era un espacio aséptico, un refugio blindado donde los avatares del mundo exterior —la crisis económica, la violencia urbana, la inestabilidad política o la incertidumbre social— quedaban suspendidos en la puerta. Se interpretaron las neurosis, las angustias y los duelos como rigurosos dramas endogámicos, donde el escenario familiar y la historia pulsional infantil bastaban para explicar toda la cartografía del padecimiento psíquico.

Sin embargo, la clínica contemporánea nos confronta de manera implacable con una realidad insoslayable: los sujetos no viven en el vacío ni flotan en una esfera abstracta. Cuando el tejido social se desgarrar, cuando la crisis económica prolongada destruye los horizontes de previsibilidad o cuando la violencia y la intemperie institucional se convierten en el paisaje cotidiano, el aparato psíquico sufre un impacto que desborda con creces la lógica del conflicto edípico tradicional.

Postulado central

El modelo de la **Clínica de la Convergencia** postula que el trauma colectivo y el colapso del lazo social no son variables sociológicas secundarias que el analista pueda desatender bajo la excusa de centrarse en "lo estrictamente psíquico".

La intemperie social golpea la puerta del consultorio transformada en:

- Insomnio crónico
- Desamparo subjetivo
- Hipervigilancia paralizante
- Somatizaciones severas

Para comprender este malestar, debemos tender un puente radical entre la **metapsicología del desamparo** (Hilflosigkeit) y la **neurobiología del estrés crónico** y el agotamiento alostático a escala poblacional.

1. Metapsicología del Desamparo y el Colapso del Otro Social

Freud introdujo el concepto de **desamparo inicial** (Hilflosigkeit) para dar cuenta de la condición prematura del cachorro humano, absolutamente dependiente del auxilienizador (Hilfe externo) no sólo para su supervivencia biológica, sino para la constitución misma de su aparato psíquico. El desamparo no es meramente una etapa infantil superada; es una condición estructural latente que el sujeto experimenta cada vez que las coordenadas simbólicas e institucionales que lo sostienen se desploman.

Cuando el lazo social entra en putrefacción o colapso, el **Gran Otro** —entendido como el orden simbólico, la ley garante, la red de instituciones que otorga sentido y contención a la existencia cotidiana— se vuelve errático, hostil o ausente. En este escenario de desprotección generalizada:

La quiebra de la promesa civilizatoria

El contrato social implícito que garantizaba que el esfuerzo, el trabajo y el cuidado mutuo tendrían un reaseguro se rompe. El futuro deja de ser una promesa de despliegue subjetivo para convertirse en una **amenaza imprevisible**.

El retorno del desamparo radical

Sin las amarras del lazo social, el yo se empobrece y retrocede hacia formas defensivas arcaicas. La angustia deja de ser señal para transformarse en **pánico automático**, y el prójimo —que debería funcionar como espejo u objeto libidinal— pasa a ser percibido como una fuente potencial de peligro y depredación.

- ❏ Este colapso simbólico no ocurre en el aire: tiene un correlato material y neurobiológico implacable sobre el cuerpo y el sistema nervioso de la población afectada.

2. Neurobiología del Estrés Crónico: El Agotamiento Alostático del Eje HPA

Desde las neurociencias afectivas y la psiconeuroinmunología, sabemos que el organismo humano cuenta con un sistema sofisticado de adaptación a las demandas del entorno: la **alostasis** (la capacidad del cuerpo de alcanzar la estabilidad a través del cambio fisiológico). Ante una amenaza aguda, el sistema nervioso simpático y el eje HPA (Hipotalámico-Pituitario-Adrenal) liberan una cascada precisa de hormonas —como el cortisol y la adrenalina— para preparar al cuerpo para la lucha o la huida.

El problema fundamental surge cuando el peligro deja de ser una emergencia episódica y se convierte en una condición crónica y estructural. Vivir en una sociedad atravesada por la precarización perpetua, la violencia urbana o la zozobra económica somete al sistema nervioso a una sobrecarga sostenida, lo que conduce inexorablemente al **agotamiento alostático** (Allostatic Load):

La fatiga del sistema de respuesta

El eje HPA, sometido a una secreción incesante de cortisol, termina desregulándose. Se observan dos perfiles neurobiológicos extremos:

- **Hipercortisolemia crónica:** estados persistentes de hipervigilancia, insomnio y ansiedad paroxística
- **Hipocortisolemia por agotamiento:** el eje se apaga, generando fatiga crónica, apatía profunda, síndromes dolorosos somáticos y depresión refractaria

El secuestro prefrontal y la neuroplasticidad negativa

El baño crónico de hormonas de estrés deteriora la plasticidad sináptica en el **hipocampo** (afectando la memoria y la capacidad de narrar el tiempo) y reduce el control inhibitorio de la **corteza prefrontal** sobre la amígdala. El cerebro del sujeto traumatizado por el entorno social vive atrapado en un estado permanente de alarma, donde el pensamiento reflexivo es reemplazado por la reactividad defensiva.

Imperativo clínico

La convergencia clínica se vuelve aquí ineludible: pretender interpretar el sufrimiento de un paciente asfixiado por el colapso social sin registrar que su Eje HPA está colapsado y su corteza prefrontal desconectada es un ejercicio de soberbia teórica que abandona al paciente a su intemperie.

Sources

- [Capítulo3.jpg](#)